

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SKRINING DAN ERADIKASI (METHICILLIN-RESISTANT <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>)		
	No. Dokumen 935.71/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra W., S.Kep., M.Kep.
Pengertian	- Merupakan prosedur untuk melakukan skrining dan eradikasi MRSA. - MRSA adalah bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> yang resisten terhadap antibiotik golongan beta lactam (oxacillin, penicillin dan derivatnya, cephalosporins, dancarbapenem). MRSA menimbulkan infeksi sistemik yang mengancam jiwa seperti sepsis, infeksi luka operasi, dan pneumonia. Terapi antibiotika untuk infeksi MRSA sangat terbatas.	
Tujuan	- Untuk menurunkan angka karier dan akuisisi MRSA pada pasien - dan petugas kesehatan sehingga angka infeksi MRSA dapat dikendalikan.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
Prosedur	Persiapan alat - Handwash. - Handscoen. - Amies transport medium (sudah termasuk lidi dacron steril). - Mupirocin salep hidung. - Cotrimoxazole 960 mg. - C Chlorhexidin gluconat 1,5% untuk rawat luka (hanya bila kultur swab luka menunjukkan positif MRSA). - Partisi untuk cohorting atau ruang isolasi (bila ada) Persiapan petugas Perhatikan tehnik aseptik dan ketepatan dalam mengambil sampel swab hidung, swab tenggorok, dan swab luka terbuka (bila ada). Pelaksanaan prosedur Perawat: - Lakukan kategorisasi pasien berdasarkan Panduan Skrining dan Eradikasi MRSA untuk menentukan pasien perlu dilakukan skrining MRSA atau tidak. - Informasikan kepada dokter yang merawat apabila pasien masuk dalam salah satu kategori untuk skrining MRSA. - Lakukan skrining MRSA dengan melakukan pengambilan sampel kultur swab hidung, swab tenggorok, dan swab luka terbuka (bila ada) terhadap pasien yang masuk dalam salah satu kategori tersebut (lihat SPO Pengambilan Sampel Skrining MRSA).	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SKRINING DAN ERADIKASI (METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS)		
	No. Dokumen 935.71/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/3
	4. Kirimkan sampel skrining MRSA (point 2) dengan lembar pengantar kultur yang bertuliskan “SKRINING MRSA” di pojok kanan atas disertai tanda-tangan dokter yang merawat ke Instalasi Mikrobiologi Klinik untuk dilakukan kultur dan identifikasi MRSA. Letakan tali elastis bagian atas ke belakang kepala bagian atas. Instalasi Mikrobiologi Klinik : 1. Lakukan kultur swab hidung, swab tenggorok, dan luka terbuka bila ada (skrining MRSA) pada medium Brilliance MRSA dalam waktu 24 jam. 2. Ilorhexidin gluconat 4% untuk mandi 3. Identifikasi koloni yang tumbuh pada medium Brilliance MRSA sebagai koloni khas MRSA atau bukan MRSA. Bandingkan dengan bakteri kontrol (ATCC) 4. Segera kirimkan hasilnya kepada dokter yang mengirim sampel kultur tersebut. Bila hasil kultur skrining MRSA menunjukkan positif MRSA maka: Perawat : 1. Lakukan cohorting (memisahkan) pasien tersebut dari pasien negatif MRSA menggunakan partisi/ruang isolasi. 2. Lakukan koordinasi dengan dokter yang merawat dan petugas farmasi untuk melakukan tindakan eradikasi terhadap pasien dengan positif MRSA. 3. Laporkan kasus positif MRSA kepada IPCLN ruangan. Dokter, Perawat, dan Petugas Farmasi: 1. Lakukan tindakan eradikasi terhadap pasien positif MRSA meliputi: 2. Pasien mandi dengan chlorhexidin gluconat 4% dua kali sehari selama 7 hari. 3. Pemberian mupirocin salep hidung 2% dua kali sehari selama hari (bila kultur swab hidung menunjukkan positif MRSA). 4. Pemberian cotrimoxazole 2x960 mg selama 7 hari (bila kultur swab tenggorok menunjukkan positif MRSA). 5. Bila terdapat luka dengan hasil kultur luka menunjukkan positif MRSA: 6. irigasi luka dengan kombinasi NS steril dan 7. chlorhexidin gluconat 1,5% setiap 3 hari sebanyak 7 kali. Bila terdapat kemajuan hasil terapi maka irigasi dilanjutkan sampai 14 kali. IPCLN : Dokumentasikan kasus karier maupun infeksi MRSA untuk kemudian dilaporkan kepada Tim PPI dan Komite PPI. Komite PPI: 1. Lakukan koordinasi dengan Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) untuk melakukan cleaning dan disinfecting ruangan dimana pasien positif MRSA dirawat. 2. Dokumentasi laporan dari IPCLN, analisa laporan tersebut dan susun rencana tindak lanjut dengan pimpinan rumah sakit. 3. Kirim laporan kejadian ke bidang evaluasi dan pelaporan.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	SKRINING DAN ERADIKASI (METHICILLIN-RESISTANT <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>)		
	No. Dokumen 935.71/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 3/3
	Pasca tindakan eradikasi MRSA Dokter dan Perawat 1. Kirimkan ulang swab hidung, swab tenggorok, dan luka terbuka (bila ada) untuk mengetahui status karier MRSA ke Instalasi Mikrobiologi Klinik. 2. Bila hasil kultur ulang menunjukkan negatif MRSA maka terapi eradikasi dinyatakan selesai. 3. Bila hasil kultur ulang masih menunjukkan positif MRSA maka terapi eradikasi diulang kembali sampai negatif. Instalasi Mikrobiologi Klinik : Bila hasil kultur ulang masih menunjukkan positif MRSA maka uji kepekaan antibiotika dilakukan terhadap isolat MRSA tersebut.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap. 2. Instalasi Laboratorium. 3. Instalasi Farmasi. 4. Komite PPI		